



NOTULEN

HARI / TANGGAL : SELASA / 12 DESEMBER 2023
PUKUL : 09:00 WIB – WIB
JENIS MEETING : KOORDINASI LAPORAN BULANAN NOVEMBER 2023
TEMPAT : HALL SAKURA LANTAI 5

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Rawat Inap	Rawat Inap perlu dikembangkan	Penambahan pelayanan rawat inap disesuaikan dengan jumlah pasien yang datang 1. Penambahan VVIP 2. Penambahan Kelas 1	Manajemen
2.	Kepuasan pasien	Di breakdown lagi nilai kepuasan pasien yang paling berpengaruh adalah: 1. Ruang tunggu 2. Perbaikan system 3. Dan SDM	1. Perlu membentuk SDM yang multi talent dan kompeten 2. Ruang Tunggu sudah ada peningkatan dan proses menunggu bangunan eksekutif 3. Perbaikan system dilakukan pada yang paling berpengaruh dalam kepuasan pasien	Manajemen
3.	Proporsi	1. Merubah kebiasaan terkait efisiensi tarif proporsi 2. Dokter bedah masih belum ada proporsional	1. Kabid dan MOD harus bisa mendampingi DPJP yang kesulitan terkait proporsi 2. Rumah Sakit perlu lebih concern ke pasien post op untuk efisiensi biaya dan dicarikan solusinya 3. Tim KMKB berdiskusi untuk control dan mengamati tarif dokter bedah dan hasil diskusi terkait efisiensi biaya di sampaikan ke DPJP terkait	Manajemen
4.	Rawat Inap	Penurunan pasien di rawat inap: 1. Analisis permasalahannya	1. Penurunnya harus di amati dari berbagai aspek dan di bedah satu persatu penyebabnya. Apabila dengan pengurangan rawat inap hasil akhirnya	Manajemen

		2. DPJP masih memikirkan kerugian akibat proporsional sehingga mengurangi pasien MRS	mendekati angka keuntungan maka merupakan hal yg bagus 2. Bedah penyebab dari DPJP mengurangi pasien MRS → apakah proporsi menjadi masalah dari DPJP? Perlu persamaan persepsi juga ke DPJP terkait proporsi apabila proporsi bukan per pasien tetapi berdasarkan hasil akhir.	
5.	Rekap Nilai BPJS	1. Skor terkait rekap nilai FKRTL apakah ada konsekuensi? 2. Pengukuran dari kepuasan FKRTL berdasarkan apa? 3. Analisa penyebab dari kepuasan menurun. 4. Aspek yg dinilai dalam aplikasi kesan? 5. TL dari BPJS apabila ada complain apakah di informasikan ke Rumah Sakit?	1. Berakibat pada kredensialing 2. Aplikasi kesan yakni aplikasi terbaru dari BPJS 3. Kepuasan pasien juga berdasarkan respon cepat saat di IGD. Rumah Sakit Perlu memperbaiki citra IGD 4. Indikator yg muncul di aplikasi kesan di compare dengan indicator yang dimiliki oleh rumah sakit 5. Rumah sakit wajib meminta feedback kepada BPJS → di compare dengan hasil yg ada di Rumah Sakit. Jangan focus di angka dan lebih berfokus kepada apa yg menjadi masalah	Manajemen
6.	Pemeliharaan ALKES	1. Maintenance ALKES masih belum bisa menyeluruh dikarenakan ALKES semakin banyak	1. Usulkan terkait tambahan SDM untuk maintenance alkes (Atem)	Manajemen
7.	Programmer	Pengajuan pada Programmer	FU terkait pengajuan yang sudah di berikan ke programmer dan yang sudah di TL mana saja	Programmer
8.	Formularium	Formularium Kit	1. Di konsultasikan ke DPJP dan disesuaikan dengan DPJP → aktifkan Kembali KFT 2. Apabila pengadaan tidak memenuhi apa yang ada di Formularium tidak	Manajemen

			masalah dijadikan bahan evaluasi 3. Yg menjadi poin penting adalah Formularium disahkan	
9.	PHS	Pasien terus mengalami peningkatan. Waspada mutu pelayanan.	Mitigasi risiko	Manajemen
10.	Tarif INAcbs	1. Selisih tarif INAcbs dari PHS dan PHM 2. Evaluasi dokter DPJP Bedah dengan LOS tinggi → dr. Zaki	1. Evaluasi apa yang menjadi penyebab dari dokter bedah LOS nya tinggi 2. Analisis dan carikan substitusi untuk efisiensi biaya 3. Diskusikan dengan DPJP terkait hasil dari analisis agar terjadi kesepakatan keduanya untuk efisiensi biaya	Manajemen
11.	CP	Efisiensi biaya melalui CP	1. Evaluasi CP dari lama perawatan dan biaya perawatan 2. Efisiensi biaya diamati secara CP sebagai bahan untuk didiskusikan Bersama dengan DPJP 3. Bisa menjadi bahan untuk diajukan ke DPJP bedah sehingga terjadi kesepakatan dua belah pihak terkait efisiensi biaya berdasarkan CP 4. Semua obat paten di hapuskan dan di substitusi dengan obat generic	Manajemen
12.		Cath lab	1. Persiapkan ruangan untuk cathlab (desain untuk cath lab) 2. Prioritaskan pengembangan pelayanan yg bisa di klaimkan → kolaborasi PHS dan PHM	Manajemen
13.	IGD ke IRNA	1. Waktu tunggu untuk pasien IGD ke IRNA masih lama	Ruang bekas farmasi di pergunakan untuk ruang tunggu transit pulang agar OB dari IGD bisa segera di naikan ke rawat inap	Manajemen



14.	Akta	Pembuatan akta hingga BPJS jangka waktunya tidak sebentar sehingga perlu di evaluasi apabila yg lama dari BPJS dan disampaikan ke pasien. Tugas RS jelas hanya menguruskan Akta sedangkan KTP KK dll harus disiapkan petugas tersendiri	Leaflet edukasi terkait alur pembuatan Akta dan berlanjut hingga pengurusan BPJS	Manajemen
15.	Alkes	Maintenance alkes masih belum maksimal dari 298 alkes yang bisa dan sempat dimanintenance hanya 134 alkes ya g lain belum sempat kurang SDM nya	1. Diajukan untuk penambahan ATEM untuk maintenance alkes aldok agar tidak rusak	Manajemen
16.	SIM-ERM	24 kasus belum terselesaikan dan tiap hari masih muncul masalah baru	Rapat khusus dengan IT Programmer (Dihin dan Candra)	Manajemen

Pemimpin Rapat
Komisaris Utama PT. Disa Prima Medika

dr. Sadi Hariono, MMRS

Malang, 12 Desember 2023
Notulis

Adinda Lestari Putri, S.KM

Mengetahui,
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika



Endang Susilowati

DOKUMENTASI

